

GUIA DE FARMACOTERAPIA PEDIÁTRICA

NEXO Clinical • edição paginada para consulta profissional

Escopo: 413 fármacos/apresentações da relação-base fornecida.

Regra de uso: conteúdo de apoio à decisão. Dose individual exige indicação, idade, peso, alergias, função renal/hepática e apresentação disponível. Medicamentos de alta vigilância requerem dupla conferência humana.

Governança: o Source Registry NEXO determina separar seleção clínica de cálculo, exigir fonte específica para estabilidade/compatibilidade/via/diluição/máximo absoluto e registrar divergências entre fontes.

Índice alfabético

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Acebrofilina | 2. Acetato de cálcio | 3. Acetazolamida |
| 4. Acetilcisteína | 5. Aciclovir | 6. Ácido acetilsalicílico (AAS) |
| 7. Ácido ascórbico (Vitamina C) | 8. Ácido fólico (Vitamina B9) | 9. Ácido fólico (Folinato de cálcio) |
| 10. Ácido mefenâmico | 11. Ácido tranexâmico | 12. Ácido ursodesoxicólico |
| 13. Ácido valproico / Valproato de sódio / Divalproato de sódio | 14. Adenosina | 15. Adrenalina (Epinefrina) |
| 16. Agalsidase beta | 17. Albendazol | 18. Alfa-dornase (Dornase alfa) |
| 19. Alglucosidase alfa | 20. Alopurinol | 21. Alprostadil (Prostaglandina E1 / PGE1) |
| 22. Amantadina (cloridrato) | 23. Ambroxol (cloridrato) | 24. Amicacina (sulfato) |
| 25. Amilorida + Hidroclorotiazida | 26. Aminofilina | 27. Amiodarona (cloridrato) |
| 28. Amitriptilina (cloridrato) | 29. Amlodipino (Besilato de anlodipino) | 30. Amoxicilina |
| 31. Amoxicilina + Clavulanato de potássio | 32. Ampicilina sódica | 33. Ampicilina + Sulbactam |
| 34. Anfotericina B (complexo lipídico) | 35. Anfotericina B (desoxicolato) | 36. Anfotericina B (lipossomal) |
| 37. Anidulafungina | 38. Aripiprazol | 39. Atenolol |
| 40. Atracúrio (besilato) | 41. Atropina (sulfato) | 42. Azatioprina |
| 43. Azitromicina | 44. Aztreonam | 45. Azul de metileno |
| 46. Baclofeno | 47. Beclometasona (dipropionato) | 48. Benzilpenicilina benzatina |
| 49. Benzilpenicilina potássica (cristalina) | 50. Benzilpenicilina procaina + Benzilpenicilina potássica | 51. Benznidazol |
| 52. Benzoato de benzila | 53. Beractanto (Surfactante pulmonar bovino) | 54. Betametasona (dipropionato / valerato / fosfato dissódico) |
| 55. Bicarbonato de sódio | 56. Bilastina | 57. Bimatoprost |
| 58. Biperideno (cloridrato / lactato) | 59. Bisacodil | 60. Bosentana |
| 61. Brimonidina (tartarato) | 62. Brometo de ipratrópio | 63. Brometo de pancurônio |
| 64. Brometo de rocurônio | 65. Brometo de tiotrópio | 66. Brometo de vecurônio |
| 67. Bromoprida | 68. Budesonida | 69. Bupivacaína (cloridrato) |
| 70. Bupropiona (cloridrato) | 71. Cafeína (Citrato de cafeína) | 72. Calcipotriol |
| 73. Calcitonina sintética de salmão | 74. Calcitriol (1,25-di-hidroxitamina D3) | 75. Canabidiol (CBD) |
| 76. Captopril | 77. Carbamazepina | 78. Carbocisteína |
| 79. Carbonato de cálcio | 80. Carvedilol | 81. Carvão vegetal ativado |
| 82. Caspofungina (acetato) | 83. Cefaclor | 84. Cefadroxila |
| 85. Cefalexina | 86. Cefalotina sódica | 87. Cefazolina sódica |
| 88. Cefepima (cloridrato) | 89. Cefixima | 90. Cefotaxima sódica |
| 91. Cefoxitina sódica | 92. Ceftazidima | 93. Ceftazidima + Avibactam |
| 94. Ceftolozana + Tazobactam | 95. Ceftriaxona sódica | 96. Cefuroxima axetila / sódica |
| 97. Celecoxibe | 98. Cetamina / Esesquetamina (cloridrato) | 99. Cetirizina (dicloridrato) |
| 100. Cetoconazol | 101. Cetoprofeno | 102. Ciclesonida |
| 103. Ciclosporina | 104. Cimetidina | 105. Ciprofloxacino (cloridrato) |
| 106. Ciproheptadina (cloridrato) | 107. Cisatracúrio (besilato) | 108. Citrato de potássio |
| 109. Claritromicina | 110. Clemastina (fumarato) | 111. Clindamicina (cloridrato / fosfato) |
| 112. Clobazam | 113. Clobetasol (propionato) | 114. Clonazepam |
| 115. Clonidina (cloridrato) | 116. Clopidogrel (bissulfato) | 117. Cloranfenicol |
| 118. Cloreto de cálcio 10% | 119. Cloreto de potássio (KCl) | 120. Cloreto de sódio (NaCl) |
| 121. Clorpromazina (cloridrato) | 122. Clotrimazol | 123. Codeína (fosfato) |
| 124. Colecalciferol (Vitamina D3) | 125. Colestiramina | 126. Colistimetato de sódio (Colistina) |
| 127. Complexo B | 128. Dantroleno sódico | 129. Daptomicina |
| 130. Deferasirox | 131. Deferoxamina (mesilato) | 132. Deflazacorte |
| 133. Desloratadina | 134. Desmopressina (acetato - DDAVP) | 135. Desonida |
| 136. Dexametasona (acetato / fosfato dissódico) | 137. Dexclorfeniramina (maleato) | 138. Dexmedetomidina (cloridrato) |
| 139. Dexpanthenol (Pró-vitamina B5) | 140. Diazepam | 141. Diazóxido |
| 142. Diclofenaco (potássico / sódico / resinato) | 143. Difenidramina (cloridrato) | 144. Digoxina |
| 145. Diltiazem (cloridrato) | 146. Dimenidrinato + Piridoxina | 147. Dimercaprol (BAL) |

148. Dipirona sódica (Metamizol)	149. Dobutamina (cloridrato)	150. Domperidona
151. Dopamina (cloridrato)	152. Doxazosina (mesilato)	153. Doxiciclina (hclato / monoidrato)
154. Dropropizina	155. Emulsão lipídica 20%	156. Enalapril (maleato) / Enalaprilato
157. Enoxaparina sódica	158. Enzimas pancreáticas (Pancreatina / Pancrelipase)	159. Epoprostenol sódico
160. Eritromicina (estolato / etilsuccinato)	161. Ertapenem sódico	162. Escitalopram (oxalato)
163. Escopolamina (Butilbrometo de escopolamina)	164. Esmolol (cloridrato)	165. Esomeprazol magnésico / sódico
166. Espironolactona	167. Etambutol (cloridrato)	168. Etomidato
169. Etossuximida	170. Fenilefrina (cloridrato)	171. Fenitoína sódica
172. Fenobarbital sódico	173. Fenoterol (bromidrato)	174. Fentanila (citrato)
175. Ferro aminoácido quelato / Bisglicinato ferroso	176. Ferro polimaltosado (Complexo de hidróxido de ferro III polimaltosado)	177. Fexofenadina (cloridrato)
178. Filgrastim (G-CSF)	179. Fisostigmina (salicilato)	180. Fitomenadiona (Vitamina K1)
181. Fluconazol	182. Flucitosina	183. Fludrocortisona (acetato)
184. Flumazenil	185. Fluoxetina (cloridrato)	186. Fluticasona (furoato / propionato)
187. Fomepizol	188. Formoterol (fumarato)	189. Foscarnet sódico
190. Fosfomicina trometamol / dissódica	191. Furosemida	192. Gabapentina
193. Galsulfase	194. Ganciclovir sódico	195. Gentamicina (sulfato)
196. Glicerina (Glicerol)	197. Glicose hipertônica	198. Glucagon
199. Gluconato de cálcio 10%	200. Griseofulvina	201. Haloperidol
202. Heparina não fracionada (sódica)	203. Hidralazina (cloridrato)	204. Hidroclorotiazida
205. Hidrocortisona (succinato sódico / acetato / butirato)	206. Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio	207. Hidróxido férrico em sacarose (Sacarato de hidróxido férrico)
208. Hidroxicloroquina (sulfato)	209. Hidroxizina (dicloridrato)	210. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)
211. Ibuprofeno	212. Idursulfase	213. Iloprost
214. Imiglucerase	215. Imipenem + Cilastatina	216. Imipramina (cloridrato)
217. Imunoglobulina humana anti-hepatite B	218. Imunoglobulina humana antirrábica	219. Imunoglobulina humana antitetânica
220. Imunoglobulina humana intravenosa (IGIV)	221. Indometacina	222. Insulina Asparte
223. Insulina Degludeca	224. Insulina Detemir	225. Insulina Glargina
226. Insulina Glulisina	227. Insulina Lispro	228. Insulina NPH (Humana)
229. Insulina Regular (Humana)	230. Iodeto de potássio	231. Isoflurano
232. Isoniazida	233. Isoprenalina (Isoproterenol)	234. Isossorbida (mononitrato / dinitrato)
235. Isavuconazol (sulfato)	236. Itraconazol	237. Ivermectina
238. Labetalol (cloridrato)	239. Lacosamida	240. Lactulose
241. Lamotrigina	242. Lansoprazol	243. Laronidase
244. Levamisol (cloridrato)	245. Levetiracetam	246. Levocetirizina (dicloridrato)
247. Levodopa + Benserazida / Carbidopa	248. Levodropropizina	249. Levofloxacino
250. Levomepromazina	251. Levosimendana	252. Levotiroxina sódica
253. Lidocaína (cloridrato)	254. Linezolida	255. Lisdexanfetamina (dimesilato)
256. Lítio (carbonato)	257. Loperamida (cloridrato)	258. Loratadina
259. Lorazepam	260. Losartana potássica	261. Macrogol 3350 / 4000 (Polietilenoglicol - PEG)
262. Mebendazol	263. Meloxicam	264. Meropenem (tri-hidratado)
265. Mesalazina	266. Metadona (cloridrato)	267. Metformina (cloridrato)
268. Metilfenidato (cloridrato)	269. Metilprednisolona (succinato sódico / acetato)	270. Metoclopramida (cloridrato)
271. Metoprolol (tartarato / succinato)	272. Metronidazol / Benzoilmetronidazol	273. Micafungina sódica
274. Miconazol (nitrato)	275. Midazolam (cloridrato / maleato)	276. Milrinona (lactato)
277. Minociclina (cloridrato)	278. Mometasona (furoato)	279. Montelukaste de sódio
280. Morfina (sulfato)	281. Moxifloxacino (cloridrato)	282. Mupirocina
283. Naloxona (cloridrato)	284. Naproxeno / Naproxeno sódico	285. Neomicina + Bacitracina
286. Neostigmina (metilsulfato)	287. Nicardipino (cloridrato)	288. Niclosamida
289. Nifedipino	290. Nimesulida	291. Nistatina
292. Nistatina + Óxido de zinco	293. Nitazoxanida	294. Nitroglicerina

295. Nitrofurantoína	296. Nitroprussiato de sódio	297. Noradrenalina (Hemitartarato de norepinefrina)
298. Nortriptilina (cloridrato)	299. Octreotida (acetato)	300. Olanzapina
301. Óleo mineral (Petróleo líquido)	302. Omalizumabe	303. Omeprazol (magnésico / sódico)
304. Ondansetrona (cloridrato)	305. Oseltamivir (fosfato)	306. Oxacilina sódica
307. Oxcarbazepina	308. Óxido de zinco	309. Oxitocina
310. Palivizumabe	311. Pantoprazol sódico	312. Paracetamol (Acetaminofeno)
313. Penicilamina	314. Periciazina	315. Permetrina
316. Picossulfato de sódio	317. Pilocarpina (cloridrato / nitrato)	318. Pimecrolimo
319. Piperacilina + Tazobactam	320. Pirantel (pamoato)	321. Pirazinamida
322. Piridostigmina (brometo)	323. Piridoxina (Vitamina B6)	324. Poliestirenosulfonato de cálcio
325. Polimixina B (sulfato)	326. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína	327. Polivitamínicos pediátricos com minerais
328. Poractanto alfa (Surfactante pulmonar porcino)	329. Posaconazol	330. Pralidoxima (mesilato)
331. Praziquantel	332. Prednisolona (fosfato sódico / acetato)	333. Prednisona
334. Pregabalina	335. Primidona	336. Probióticos pediátricos (Lactobacillus reuteri / rhamnosus / Saccharomyces boulardii)
337. Prometazina (cloridrato)	338. Propiltiouracila	339. Propofol
340. Propranolol (cloridrato)	341. Protamina (cloridrato / sulfato)	342. Quetiapina (fumarato)
343. Racecadotril	344. Ranitidina (cloridrato)	345. Remifentanila (cloridrato)
346. Retinol (Vitamina A / Palmitato de retinol)	347. Ribavirina	348. Rifampicina
349. Risperidona	350. Rufinamida	351. Rupatadina (fumarato)
352. Sais de Reidratação Oral (SRO)	353. Salbutamol (sulfato)	354. Salmeterol (xinafoato)
355. Secnidazol	356. Sertralina (cloridrato)	357. Sevelamer (carbonato)
358. Sevoflurano	359. Sildenafil (citrato)	360. Simeticona (Dimeticona)
361. Somatropina (Hormônio do crescimento recombinante - rhGH)	362. Soro antiaracnídico	363. Soro antibotrópico (pentavalente)
364. Soro antibotulínico (AB bivalente / trivalente)	365. Soro anticrotático	366. Soro antidiftérico
367. Soro antielapídico (bivalente)	368. Soro antiescorpiônico	369. Soro antilaquéutico
370. Soro antitetânico	371. Succinato de metoprolol	372. Succinilcolina (Cloreto de suxametônio)
373. Sucralfato	374. Sufentanila (citrato)	375. Sugamadex
376. Sulfadiazina	377. Sulfadiazina de prata	378. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-trimoxazol)
379. Sulfassalazina	380. Sulfato de magnésio	381. Sulfato de zinco / Bisglicinato de zinco
382. Sulfato ferroso	383. Sulpirida	384. Tacrolimo
385. Tadalafila	386. Teicoplanina	387. Teofilina
388. Terbinafina (cloridrato)	389. Terbutalina (sulfato)	390. Tiabendazol
391. Tiamazol (Metimazol)	392. Tiamina (Vitamina B1)	393. Tiaprida (cloridrato)
394. Tigeciclina	395. Timolol (maleato)	396. Tinidazol
397. Tobramicina	398. Tocoferol (Acetato de racealfatocoferol / Vitamina E)	399. Topiramato
400. Tramadol (cloridrato)	401. Triancinolona acetona	402. Trimebutina (maleato)
403. Urapidil	404. Valaciclovir (cloridrato)	405. Valganciclovir (cloridrato)
406. Vancomicina (cloridrato)	407. Varfarina sódica	408. Vasopressina
409. Verapamil (cloridrato)	410. Vigabatrina	411. Voriconazol
412. Zanamivir	413. Zonisamida	

1. Acebrofilina

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope pediátrico 25 mg/5 mL [5 mg/mL], xarope adulto 50 mg/5 mL [10 mg/mL], gotas 50 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Broncodilatador e mucolítico adjuvante em afecções do trato respiratório inferior; não é fármaco de resgate do broncoespasmo agudo grave.
POSOLOGIA	2–3 anos: 2 mg/kg/dia, dividido 12/12 h. 3–6 anos: 25 mg 12/12 h. 6–12 anos: 25–50 mg 12/12 h.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Via oral. No modelo: xarope pediátrico 5 mg/mL; 25 mg = 5 mL; 50 mg = 10 mL.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Contraindicado no modelo em <2 anos. Hipersensibilidade à fórmula/outras xantinas.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

2. Acetato de cálcio

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 500 mg e 667 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

3. Acetazolamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

4. Acetilcisteína

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope pediátrico 20 mg/mL [100 mg/5 mL], xarope adulto 40 mg/mL [200 mg/5 mL], granulado/sachê 100 mg, 200 mg e 600 mg, solução injetável/inalatória 100 mg/mL [ampola 3 mL = 300 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Mucolítico; antídoto de primeira linha na intoxicação aguda por paracetamol.
POSOLOGIA	Mucolítico VO: 2–4 anos 100 mg 2–3x/dia; >4 anos 100 mg 3–4x/dia (ou 600 mg/dia divididos). Intoxicação IV: 150 mg/kg em 1 h → 50 mg/kg em 4 h → 100 mg/kg em 16 h.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Apresentações do modelo: 20 mg/mL e 40 mg/mL VO; 100 mg/mL injetável/inalatória. Para IV, seguir protocolo toxicológico e apresentação efetiva.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Mucolítico contraindicado no modelo em <2 anos; cautela em asma e úlcera gastroduodenal ativa.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

5. Aciclovir

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 200 mg/5 mL [40 mg/mL], comprimidos 200 mg e 400 mg, pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 250 mg, creme dermatológico 50 mg/g [5%], pomada oftálmica 30 mg/g [3%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	HSV/VZV; primeira linha em HSV neonatal, encefalite herpética e outras infecções herpéticas graves.
POSOLOGIA	Varicela VO: 20 mg/kg/dose 4x/dia (máx. 800 mg/dose), 5 dias. HSV neonatal/encefalite IV: 20 mg/kg/dose 8/8 h, 14–21 dias. Gengivostomatite grave VO: 15–20 mg/kg/dose 8/8 h.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	IV lenta, mínimo 1 h no modelo. Hidratação adequada. Suspensão oral do modelo: 40 mg/mL.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Ajustar à função renal; risco de nefropatia por cristalização na via IV.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

6. Ácido acetilsalicílico (AAS)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg infantil e 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Uso pediátrico restrito: doença de Kawasaki e febre reumática; não usar rotineiramente como antitérmico/analgésico.
POSOLOGIA	Kawasaki aguda: 80–100 mg/kg/dia ÷ 6/6 h até 48 h após defervescência; manutenção 3–5 mg/kg/dia 1x/dia por 6–8 semanas ou conforme coronárias. Febre reumática: 50–70 mg/kg/dia ÷ 6–8 h.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Via oral.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Evitar/contraindicar em doença febril viral pelo risco de síndrome de Reye.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

7. Ácido ascórbico (Vitamina C)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 200 mg/mL [10 mg/gota], solução oral 100 mg/mL, comprimidos efervescentes 500 mg e 1 g, solução injetável 100 mg/mL [ampola 5 mL = 500 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

8. Ácido fólico (Vitamina B9)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 0,2 mg/mL, solução oral 1 mg/mL, comprimidos 2 mg e 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

9. Ácido folínico (Folinato de cálcio)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 15 mg, solução injetável 3 mg/mL e 10 mg/mL [ampolas e frascos-ampola]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

10. Ácido mefenâmico

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 50 mg/5 mL [10 mg/mL], comprimidos 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

11. Ácido tranexâmico

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 250 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampola 5 mL = 250 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

12. Ácido ursodesoxicólico

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas/comprimidos 50 mg, 150 mg e 300 mg, suspensão oral 50 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

13. Ácido valproico / Valproato de sódio / Divalproato de sódio

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 250 mg/5 mL [50 mg/mL], gotas 200 mg/mL, cápsulas 250 mg, comprimidos revestidos/liberação prolongada 250 mg, 300 mg e 500 mg, solução injetável IV 100 mg/mL [frasco-ampola 5 mL = 500 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

14. Adenosina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 3 mg/mL [ampola 2 mL = 6 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

15. Adrenalina (Epinefrina)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1 mg/mL [1:1000, ampola 1 mL]
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

16. Agalsidase beta

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 35 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

17. Albendazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 40 mg/mL [frasco 10 mL = 400 mg], comprimidos mastigáveis 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

18. Alfa-dornase (Dornase alfa)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para inalação 1 mg/mL [ampola 2,5 mL = 2,5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

19. Alglucosidase alfa

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

20. Alopurinol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 300 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

21. Alprostadil (Prostaglandina E1 / PGE1)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 500 mcg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

22. Amantadina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

23. Ambroxol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope pediátrico 15 mg/5 mL [3 mg/mL], xarope adulto 30 mg/5 mL [6 mg/mL], gotas 7,5 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

24. Amicacina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 50 mg/mL, 125 mg/mL e 250 mg/mL [ampolas de 2 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

25. Amilorida + Hidroclorotiazida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 2,5 mg + 25 mg e 5 mg + 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

26. Aminofilina

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas/solução oral 240 mg/mL, comprimidos 100 mg e 200 mg, solução injetável 24 mg/mL [ampola 10 mL = 240 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

27. Amiodarona (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 200 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampola 3 mL = 150 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

28. Amitriptilina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 10 mg, 25 mg e 75 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

29. Amlodipino (Besilato de anlodipino)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 2,5 mg, 5 mg e 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

30. Amoxicilina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 250 mg/5 mL, 400 mg/5 mL e 500 mg/5 mL, cápsulas/comprimidos 500 mg e 875 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	OMA, sinusite bacteriana e PAC típica não grave, entre outras infecções suscetíveis, conforme diagnóstico.
POSOLOGIA	Padrão: 40–50 mg/kg/dia divididos. Dose alta: 80–90 mg/kg/dia divididos 8/8–12/12 h. Profilaxia de endocardite: 50 mg/kg (máx. 2 g) 30–60 min antes do procedimento.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Via oral; selecionar concentração efetivamente disponível antes da conversão para mL.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Evitar em hipersensibilidade grave a beta-lactâmicos. EBV/CMV associa-se a alto risco de exantema.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

31. Amoxicilina + Clavulanato de potássio

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 125+31,25 mg/5 mL, 250+62,5 mg/5 mL, 200+28,5 mg/5 mL, 400+57 mg/5 mL e 600+42,9 mg/5 mL [ES], comprimidos 500+125 mg e 875+125 mg, pó liofilizado para solução injetável IV 500+100 mg e 1000+200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Cobertura de produtores de beta-lactamase; falha terapêutica, mordeduras e cenários selecionados.
POSOLOGIA	Calcular pela amoxicilina-base. O modelo utiliza 40–50 mg/kg/dia (padrão) ou 80–90 mg/kg/dia (alta dose), conforme indicação e formulação.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Via oral/IV conforme apresentação. Conferir a razão amoxicilina:clavulanato para limitar exposição ao clavulanato.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Mesmas precauções de hipersensibilidade dos beta-lactâmicos.
FONTE CLÍNICA	Modelo clínico anexado — Guia de Farmacoterapia Pediátrica, Vol. 1.

32. Ampicilina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 250 mg/5 mL, cápsulas 500 mg, pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1000 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

33. Ampicilina + Sulbactam

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1,5 g [1000 mg + 500 mg] e 3 g [2000 mg + 1000 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

34. Anfotericina B (complexo lipídico)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão injetável concentrada para infusão 5 mg/mL [frasco 20 mL = 100 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

35. Anfotericina B (desoxicolato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

36. Anfotericina B (lipossomal)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

37. Anidulafungina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

38. Aripiprazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 1 mg/mL, gotas 1 mg/gota, comprimidos 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

39. Atenolol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

40. Atracúrio (besilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 10 mg/mL [ampolas de 2,5 mL e 5 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

41. Atropina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL [ampolas de 1 mL], colírio oftálmico 0,5% e 1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

42. Azatioprina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

43. Azitromicina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 200 mg/5 mL [frascos 600 mg, 900 mg e 1500 mg], comprimidos 500 mg, pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

44. Aztreonam

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

45. Azul de metileno

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1% [10 mg/mL, ampola 5 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

46. Baclofeno

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 10 mg e 25 mg, solução intratecal 0,05 mg/mL e 0,5 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

47. Beclometasona (dipropionato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal aquoso 50 mcg/dose, aerossol inalatório oral pressurizado 50 mcg, 200 mcg e 250 mcg/dose, cápsulas com pó inalatório 200 mcg e 400 mcg, suspensão para nebulização 400 mcg/mL e 800 mcg/2 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

48. Benzilpenicilina benzatina

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão injetável frasco-ampola 600.000 UI e 1.200.000 UI [via IM exclusiva]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

49. Benzilpenicilina potássica (cristalina)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 5.000.000 UI e 10.000.000 UI [via IV]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

50. Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI [400.000 UI, via IM]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

51. Benznidazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 12,5 mg pediátrico e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

52. Benzoato de benzila

APRESENTAÇÕES DA BASE	emulsão tópica/loção 250 mg/mL [25%] e sabonete
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

53. Beractanto (Surfactante pulmonar bovino)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão intratraqueal 25 mg/mL [frascos de 4 mL = 100 mg e 8 mL = 200 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

54. Betametasona (dipropionato / valerato / fosfato dissódico)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 0,5 mg/mL, elixir 0,1 mg/mL, comprimidos 0,5 mg e 2 mg, solução injetável 4 mg/mL e 5,3 mg/mL, creme/pomada tópica 1 mg/g [0,1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

55. Bicarbonato de sódio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 8,4% [1 mEq/mL, ampolas 10 mL e frascos 250 mL] e 10%, pó para solução oral
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

56. Bilastina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 2,5 mg/mL, comprimidos orodispersíveis 10 mg, comprimidos 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

57. Bimatoprost

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oftálmica/colírio 0,01% e 0,03%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

58. Biperideno (cloridrato / lactato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 2 mg e 4 mg [liberação prolongada], solução injetável 5 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

59. Bisacodil

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 7,5 mg/mL, comprimidos revestidos 5 mg, supositórios pediátricos 5 mg e adultos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

60. Bosentana

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos dispersíveis 32 mg, comprimidos revestidos 62,5 mg e 125 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

61. Brimonidina (tartarato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oftálmica/colírio 0,15% e 0,2%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

62. Brometo de ipratrópio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para inalação/nebulização 0,25 mg/mL [0,02 mg/gota], aerossol inalatório pressurizado 20 mcg/puff, spray nasal 0,03%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

63. Brometo de pancurônio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 2 mg/mL [ampola 2 mL = 4 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

64. Brometo de rocurônio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 10 mg/mL [frasco-ampola 5 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

65. Brometo de tiotrópio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para inalação névoa fina respimat 2,5 mcg/puff, cápsulas com pó para inalação 18 mcg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

66. Brometo de vecurônio

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 4 mg e 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

67. Bromoprida

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 4 mg/mL, solução oral 1 mg/mL, cápsulas 10 mg, solução injetável 5 mg/mL [ampola 2 mL = 10 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

68. Budesonida

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão para nebulização 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL [flaconetes 2 mL], spray nasal aquoso 32 mcg, 50 mcg, 64 mcg e 100 mcg/dose, pó inalatório em cápsulas ou dispositivo turbuhaler 100 mcg, 200 mcg e 400 mcg/dose, cápsulas de liberação ileal 3 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

69. Bupivacaína (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,25%, 0,5% sem vasoconstritor e 0,5% pesada [isobárica/hiperbárica]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

70. Bupropiona (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos de liberação prolongada 150 mg e 300 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

71. Cafeína (Citrato de cafeína)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 20 mg/mL [equivalente a 10 mg/mL de cafeína base], solução injetável 20 mg/mL [ampolas 1 mL e 2 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

72. Calcipotriol

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica 50 mcg/g [0,005%], loção tópica
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

73. Calcitonina sintética de salmão

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal 200 UI/dose, solução injetável 100 UI/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

74. Calcitriol (1,25-di-hidroxivitamina D3)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas gelatinosas 0,25 mcg, solução injetável 1 mcg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

75. Canabidiol (CBD)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/gotas 20 mg/mL, 50 mg/mL, 100 mg/mL, 150 mg/mL e 200 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

76. Captopril

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 12,5 mg, 25 mg e 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

77. Carbamazepina

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 100 mg/5 mL [20 mg/mL], comprimidos 200 mg e 400 mg, comprimidos de liberação controlada 200 mg e 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

78. Carbocisteína

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope pediátrico 20 mg/mL [100 mg/5 mL], xarope adulto 50 mg/mL [250 mg/5 mL], gotas 50 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

79. Carbonato de cálcio

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos mastigáveis 500 mg e 1250 mg [500 mg de Ca elementar], suspensão oral
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

80. Carvedilol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

81. Carvão vegetal ativado

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral em frasco/pote de 25 g e 50 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

82. Caspofungina (acetato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg e 70 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

83. Cefaclor

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 125 mg/5 mL, 250 mg/5 mL e 375 mg/5 mL, cápsulas 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

84. Cefadroxila

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL, cápsulas 500 mg
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

85. Cefalexina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL, cápsulas/comprimidos 500 mg e 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

86. Cefalotina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

87. Cefazolina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

88. Cefepima (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g e 2 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

89. Cefixima

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 100 mg/5 mL, cápsulas 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

90. Cefotaxima sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

91. Cefoxitina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

92. Ceftazidima

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 1 g e 2 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

93. Ceftazidima + Avibactam

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 2 g + 0,5 g [2,5 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

94. Ceftolozana + Tazobactam

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 1 g + 0,5 g [1,5 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

95. Ceftriaxona sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g [IV ou IM com lidocaína]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

96. Cefuroxima axetila / sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL, comprimidos revestidos 250 mg e 500 mg, pó para solução injetável frasco-ampola 750 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

97. Celecoxibe

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 100 mg e 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

98. Cetamina / Esesquetamina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 50 mg/mL [frascos de 2 mL e 10 mL] e 25 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

99. Cetirizina (dicloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 10 mg/mL, solução oral/xarope 1 mg/mL, comprimidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

100. Cetoconazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme dermatológico 20 mg/g [2%], xampu 20 mg/g [2%], comprimidos 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

101. Cetoprofeno

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 20 mg/mL [1 mg/gota], suspensão oral pediátrica, comprimidos 50 mg e 100 mg, solução injetável IM/IV 100 mg [ampola 2 mL ou frasco-ampola liofilizado]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

102. Ciclesonida

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal 50 mcg/dose, aerossol inalatório oral 80 mcg e 160 mcg/dose
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

103. Ciclosporina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 100 mg/mL, cápsulas gelatinosas 25 mg, 50 mg e 100 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampola 1 mL e 5 mL], colírio oftálmico 0,05%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

104. Cimetidina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 200 mg/5 mL, comprimidos 200 mg e 400 mg, solução injetável 150 mg/mL [ampola 2 mL = 300 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

105. Ciprofloxacino (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 250 mg/5 mL, comprimidos 250 mg e 500 mg, solução para infusão IV 2 mg/mL [bolsas 100 mL = 200 mg e 200 mL = 400 mg], colírio/pomada oftálmica 0,3%, gotas otológicas 0,3%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

106. Cipropeptadina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 2 mg/5 mL [associado a vitaminas/aminoácidos]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

107. Cisatracúrio (besilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 2 mg/mL [ampolas 5 mL = 10 mg e 10 mL = 20 mg] e 10 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

108. Citrato de potássio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 2 mEq/mL [1080 mg/10 mL], granulado/sachê
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

109. Claritromicina

APRESENTAÇÕES DA BASE	grânulos para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL, comprimidos 250 mg e 500 mg, pó liofilizado para solução injetável 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

110. Clemastina (fumarato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 0,05 mg/mL, comprimidos 1 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

111. Clindamicina (cloridrato / fosfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 75 mg/5 mL, cápsulas 300 mg, solução injetável 150 mg/mL [ampolas 2 mL = 300 mg, 4 mL = 600 mg e 6 mL = 900 mg], gel/solução tópica 1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

112. Clobazam

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 10 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

113. Clobetasol (propionato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme, pomada e solução capilar 0,5 mg/g [0,05%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

114. Clonazepam

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 2,5 mg/mL [0,1 mg/gota], comprimidos 0,5 mg e 2 mg, comprimidos orodispersíveis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

115. Clonidina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 0,100 mg, 0,150 mg e 0,200 mg, solução injetável 150 mcg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

116. Clopidogrel (bissulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 75 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

117. Cloranfenicol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 125 mg/5 mL [palmitato], cápsulas 250 mg e 500 mg, pó injetável frasco-ampola 1 g [succinato], colírio 0,4% e 0,5%, pomada oftálmica 10 mg/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

118. Cloreto de cálcio 10%

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 100 mg/mL [10%, ampola 10 mL = 1 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

119. Cloreto de potássio (KCl)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 6% [60 mg/mL] e 10% [100 mg/mL], comprimidos de liberação controlada 600 mg [8 mEq], solução injetável concentrada 10% [1,34 mEq/mL] e 19,1% [2,56 mEq/mL] em ampolas de 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

120. Cloreto de sódio (NaCl)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução nasal 0,9% [gotas e spray com jato contínuo] e 3% [spray hipertônico], solução injetável/infusão 0,9% [bolsas/frascos 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL], solução injetável hipertônica 10% e 20% em ampolas de 10 mL e 20 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

121. Clorpromazina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 40 mg/mL [1 mg/gota], comprimidos 25 mg e 100 mg, solução injetável 5 mg/mL [ampola 5 mL = 25 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

122. Clotrimazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme dermatológico 10 mg/g [1%], solução tópica 10 mg/mL, creme vaginal 10 mg/g e 20 mg/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

123. Codeína (fosfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 3 mg/mL, comprimidos 30 mg e 60 mg, solução injetável 30 mg/mL [ampola 2 mL = 60 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

124. Colecalciferol (Vitamina D3)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 200 UI/gota, 500 UI/gota e 1000 UI/gota, solução oral 2.000 UI/mL e 10.000 UI/mL, cápsulas gelatinosas 1.000 UI, 2.000 UI, 5.000 UI, 7.000 UI, 10.000 UI e 50.000 UI, ampolas injetáveis IM
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

125. Colestiramina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral em envelopes/sachês de 4 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

126. Colistimetato de sódio (Colistina)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável/inalatória 1.000.000 UI [aprox. 80 mg] e 2.000.000 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

127. Complexo B

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas pediátricas, xarope/solução oral, comprimidos/drágeas, solução injetável em ampolas de 2 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

128. Dantroleno sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 20 mg em frasco-ampola com diluente estéril, cápsulas 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

129. Daptomicina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

130. Deferasirox

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos dispersíveis 125 mg, 250 mg e 500 mg, comprimidos revestidos 90 mg, 180 mg e 360 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

131. Deferoxamina (mesilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 2 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

132. Deflazacorte

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 22,75 mg/mL [1 mg/gota], suspensão oral 22,75 mg/mL, comprimidos 6 mg e 30 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

133. Desloratadina

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope/solução oral 0,5 mg/mL, gotas 1,25 mg/mL e 2,5 mg/mL, comprimidos orodispersíveis 2,5 mg e 5 mg, comprimidos revestidos 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

134. Desmopressina (acetato - DDAVP)

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal 0,1 mg/mL [10 mcg/dose], solução nasal 0,1 mg/mL [com cânula graduada], comprimidos 0,1 mg e 0,2 mg, comprimidos orodispersíveis sublinguais [MELT] 60 mcg, 120 mcg e 240 mcg, solução injetável 4 mcg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

135. Desonida

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme, pomada e loção dermatológica 0,5 mg/g [0,05%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

136. Dexametasona (acetato / fosfato dissódico)

APRESENTAÇÕES DA BASE	elixir/solução oral 0,1 mg/mL [0,5 mg/5 mL], comprimidos 0,5 mg, 0,75 mg e 4 mg, solução injetável 2 mg/mL e 4 mg/mL [ampolas 1 mL e 2,5 mL], colírio oftálmico 0,1%, pomada oftálmica 0,1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

137. Dexclorfeniramina (maleato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 2 mg/5 mL [0,4 mg/mL], gotas 2,8 mg/mL [0,1 mg/gota], comprimidos 2 mg, drágeas de liberação prolongada 6 mg, creme dermatológico 10 mg/g [1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

138. Dexmedetomidina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 100 mcg/mL [frasco-ampola 2 mL = 200 mcg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

139. Dexpantenol (Pró-vitamina B5)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica 50 mg/g [5%], solução líquida tópica/oral 5%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

140. Diazepam

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 5 mg e 10 mg, solução injetável 5 mg/mL [ampola 2 mL = 10 mg], bisnaga/solução retal
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

141. Diazóxido

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 25 mg e 100 mg, suspensão oral 50 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

142. Diclofenaco (potássico / sódico / resinato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 15 mg/mL [resinato - 0,5 mg/gota], comprimidos dispersíveis 50 mg, drágeas/comprimidos 50 mg, supositórios 12,5 mg, 25 mg e 50 mg, solução injetável 75 mg/3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

143. Difenidramina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 2,5 mg/mL, solução injetável 50 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

144. Digoxina

APRESENTAÇÕES DA BASE	elixir pediátrico/solução oral 0,05 mg/mL [50 mcg/mL], comprimidos 0,25 mg, solução injetável 0,25 mg/mL [ampola 2 mL = 0,5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

145. Diltiazem (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 30 mg e 60 mg, pó injetável 25 mg e 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

146. Dimenidrinato + Piridoxina

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL [1,25 mg/gota], solução oral 12,5 mg/5 mL + 5 mg/5 mL, comprimidos 50 mg + 10 mg e 100 mg + 10 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

147. Dimercaprol (BAL)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável oleosa 100 mg/mL [ampola 3 mL = 300 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

148. Dipirona sódica (Metamizol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 500 mg/mL [25 mg/gota], solução oral 50 mg/mL, comprimidos 500 mg e 1 g, supositórios 300 mg, solução injetável 500 mg/mL [ampolas 2 mL = 1 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

149. Dobutamina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 12,5 mg/mL [ampola 20 mL = 250 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

150. Domperidona

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 1 mg/mL, comprimidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

151. Dopamina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 5 mg/mL [ampola 10 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

152. Doxazosina (mesilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 2 mg e 4 mg
-----------------------	-------------------------

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

153. Doxíciclina (hiclato / monoidrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos solúveis/revestidos 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

154. Dropropizina

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope pediátrico 1,5 mg/mL [7,5 mg/5 mL], xarope adulto 3 mg/mL [15 mg/5 mL], gotas 30 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

155. Emulsão lipídica 20%

APRESENTAÇÕES DA BASE	emulsão estéril para infusão IV 200 mg/mL [frascos de 100 mL, 250 mL e 500 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

156. Enalapril (maleato) / Enalaprilato

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg, enalaprilato injetável 1,25 mg/mL [ampola 1 mL ou 2 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

157. Enoxaparina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável em seringas preenchidas com sistema de segurança 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL, 60 mg/0,6 mL, 80 mg/0,8 mL e 100 mg/1,0 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

158. Enzimas pancreáticas (Pancreatina / Pancrelipase)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes de 10.000 UI, 25.000 UI e 40.000 UI de lipase
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

159. Epoprostenol sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável para infusão contínua 0,5 mg e 1,5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

160. Eritromicina (estolato / etilsuccinato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL, comprimidos 250 mg e 500 mg, pomada oftálmica 0,5%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

161. Ertapenem sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

162. Escitalopram (oxalato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 20 mg/mL [1 mg/gota], comprimidos 10 mg, 15 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

163. Escopolamina (Butilbrometo de escopolamina)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 10 mg/mL [0,5 mg/gota], solução oral, comprimidos 10 mg, solução injetável 20 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

164. Esmolol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 10 mg/mL [frasco 10 mL = 100 mg] e solução concentrada para diluição 250 mg/mL [ampola 10 mL = 2500 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

165. Esomeprazol magnésico / sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	grânulos gastrorresistentes para suspensão oral em sachês de 10 mg, comprimidos 20 mg e 40 mg, pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

166. Espironolactona

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

167. Etambutol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

168. Etomidato

APRESENTAÇÕES DA BASE	emulsão/solução injetável 2 mg/mL [ampola 10 mL = 20 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

169. Etossuximida

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 250 mg/5 mL [50 mg/mL], cápsulas 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

170. Fenilefrina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução nasal 0,5 mg/mL [0,05%] e 1 mg/mL [0,1%], colírio oftálmico 2,5% e 10%, solução injetável 10 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

171. Fenitoína sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 100 mg/5 mL [20 mg/mL], comprimidos 100 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampola 5 mL = 250 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

172. Fenobarbital sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 40 mg/mL [1 mg/gota], comprimidos 100 mg, solução injetável 100 mg/mL [ampola 2 mL = 200 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

173. Fenoterol (bromidrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas para inalação/nebulização 5 mg/mL [0,25 mg/gota], aerossol inalatório pressurizado 100 mcg/puff
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

174. Fentanila (citrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 50 mcg/mL [ampolas de 2 mL = 100 mcg, 5 mL = 250 mcg e 10 mL = 500 mcg], adesivo transdérmico 12 mcg/h, 25 mcg/h e 50 mcg/h
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

175. Ferro aminoácido quelato / Bisglicinato ferroso

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 15 mg/mL e 30 mg/mL de ferro elementar, solução oral, comprimidos
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

176. Ferro polimaltosado (Complexo de hidróxido de ferro III polimaltosado)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 50 mg/mL de ferro elementar [2,5 mg/gota], xarope 10 mg/mL de ferro elementar [50 mg/5 mL], comprimidos mastigáveis 100 mg de ferro elementar, solução injetável IM 100 mg/2 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

177. Fexofenadina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 6 mg/mL [30 mg/5 mL], comprimidos revestidos 30 mg, 60 mg, 120 mg e 180 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

178. Filgrastim (G-CSF)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável em frasco-ampola ou seringa preenchida 300 mcg/mL [30 MU = 300 mcg/1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

179. Fisostigmina (salicilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

180. Fitomenadiona (Vitamina K1)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 2 mg/0,2 mL [pediátrica] e 10 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

181. Fluconazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 50 mg/5 mL e 200 mg/5 mL, cápsulas 50 mg, 100 mg e 150 mg, solução para infusão IV 2 mg/mL [bolsa 100 mL = 200 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

182. Flucitosina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para infusão IV 10 mg/mL, cápsulas 250 mg e 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

183. Fludrocortisona (acetato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 0,1 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

184. Flumazenil

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,1 mg/mL [ampola 5 mL = 0,5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

185. Fluoxetina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 20 mg/mL [1 mg/gota], cápsulas/comprimidos 10 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

186. Fluticasona (furoato / propionato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal aquoso 27,5 mcg e 50 mcg/dose, aerossol inalatório pressurizado 50 mcg, 125 mcg e 250 mcg/dose, cápsulas com pó para inalação 50 mcg, 100 mcg e 250 mcg/dose, creme/pomada dermatológica 0,5 mg/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

187. Fomepizol

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1 g/mL [frasco-ampola 1,5 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

188. Formoterol (fumarato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas com pó para inalação 12 mcg, associado a budesonida [6/100 mcg, 6/200 mcg e 12/400 mcg], associado a beclometasona [6/100 mcg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

189. Foscarnet sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para infusão IV 24 mg/mL [frasco 250 mL = 6 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

190. Fosfomicina trometamol / dissódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	granulado para solução oral em sachê de 3 g, pó para solução injetável IV frasco-ampola 1 g e 4 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

191. Furosemida

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas/solução oral 10 mg/mL, comprimidos 40 mg, solução injetável 10 mg/mL [ampola 2 mL = 20 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

192. Gabapentina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 300 mg e 400 mg, comprimidos 600 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

193. Galsulfase

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução concentrada para infusão 1 mg/mL [frasco 5 mL = 5 mg]
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

194. Ganciclovir sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg, gel oftálmico 0,15%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

195. Gentamicina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 10 mg/mL, 20 mg/mL, 40 mg/mL e 80 mg/2 mL [ampolas de 1 mL e 2 mL], colírio/pomada oftálmica 0,3%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

196. Glicerina (Glicerol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução retal em enema/clister 12%, supositórios retais pediátricos [1 g a 1,5 g] e adultos [2,5 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

197. Glicose hipertônica

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada 25% e 50% [ampolas de 10 mL e 20 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

198. Glucagon

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg com seringa de diluente de 1 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

199. Gluconato de cálcio 10%

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 100 mg/mL [10%, ampola 10 mL = 1 g / 0,45 mEq/mL de cálcio elementar]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

200. Griseofulvina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

201. Haloperidol

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 2 mg/mL [0,1 mg/gota], comprimidos 1 mg e 5 mg, solução injetável 5 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

202. Heparina não fracionada (sódica)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 5.000 UI/mL [frasco 5 mL = 25.000 UI] e 5.000 UI/0,25 mL [via SC]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

203. Hidralazina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos/drágeas 25 mg e 50 mg, solução injetável 20 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

204. Hidroclorotiazida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg e 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

205. Hidrocortisona (succinato sódico / acetato / butirato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg e 500 mg, comprimidos 10 mg e 20 mg, creme/pomada dermatológica 10 mg/g [1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

206. Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 35,6 mg/mL + 37 mg/mL, comprimidos mastigáveis
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

207. Hidróxido férrico em sacarose (Sacarato de hidróxido férrico)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável para infusão IV 20 mg/mL de ferro elementar [ampola 5 mL = 100 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

208. Hidroxicloroquina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

209. Hidroxizina (dicloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 2 mg/mL [10 mg/5 mL], comprimidos 25 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

210. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1.000 mcg/mL e 5.000 mcg/2 mL [ampolas IM]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

211. Ibuprofeno

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 50 mg/mL [2,5 mg/gota] e 100 mg/mL [5 mg/gota], suspensão oral 20 mg/mL [100 mg/5 mL] e 30 mg/mL, comprimidos 200 mg, 300 mg, 400 mg e 600 mg, solução injetável IV 10 mg/mL [ampola 2 mL = 20 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

212. Idursulfase

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução concentrada para infusão 2 mg/mL [frasco 3 mL = 6 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

213. Iloprost

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para inalação 10 mcg/mL e 20 mcg/mL [ampolas 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

214. Imiglucerase

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 UI e 400 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

215. Imipenem + Cilastatina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg + 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

216. Imipramina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos/drágeas 10 mg, 25 mg e 75 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

217. Imunoglobulina humana anti-hepatite B

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável em frasco-ampola 100 UI, 500 UI e 1000 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

218. Imunoglobulina humana antirrábica

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 150 UI/mL [frasco-ampola 2 mL = 300 UI e 5 mL = 750 UI]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

219. Imunoglobulina humana antitetânica

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável em frasco-ampola ou seringa preenchida 250 UI e 500 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

220. Imunoglobulina humana intravenosa (IGIV)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução estéril para infusão IV 5 g/100 mL [5%] e 10 g/100 mL [10%] em frascos de 50 mL, 100 mL e 200 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

221. Indometacina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 25 mg e 50 mg, pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

222. Insulina Asparte

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta preenchida 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

223. Insulina Degludeca

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável ultralarga 100 UI/mL em caneta preenchida 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

224. Insulina Detemir

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável longa 100 UI/mL em caneta preenchida 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

225. Insulina Glargina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável longa 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL, e 300 UI/mL em caneta 1,5 mL
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

226. Insulina Glulisina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

227. Insulina Lispro

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

228. Insulina NPH (Humana)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão injetável intermediária 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

229. Insulina Regular (Humana)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável rápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

230. Iodeto de potássio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 20 mg/mL e 100 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

231. Isoflurano

APRESENTAÇÕES DA BASE	líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 240 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

232. Isoniazida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 300 mg, comprimidos em dose fixa combinada [RH / RHZE]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

233. Isoprenalina (Isoproterenol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,2 mg/mL [ampola 1 mL e 5 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

234. Isossorbida (mononitrato / dinitrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos sublinguais 5 mg, comprimidos 10 mg, 20 mg e 40 mg, solução injetável 1 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

235. Isavuconazol (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 100 mg, pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

236. Itraconazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 10 mg/mL, cápsulas 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

237. Ivermectina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 6 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

238. Labetalol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 200 mg, solução injetável 5 mg/mL [frasco-ampola 20 mL = 100 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

239. Lacosamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 10 mg/mL, comprimidos 50 mg, 100 mg, 150 mg e 200 mg, solução para infusão IV 10 mg/mL [frasco 20 mL = 200 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

240. Lactulose

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 667 mg/mL [66,7%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

241. Lamotrigina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos dispersíveis/mastigáveis 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

242. Lansoprazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes 15 mg e 30 mg, comprimidos orodispersíveis 15 mg e 30 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

243. Laronidase

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução concentrada para infusão 0,58 mg/mL [frasco 5 mL = 2,9 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

244. Levamisol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 80 mg e 150 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

245. Levetiracetam

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 100 mg/mL, comprimidos revestidos 250 mg, 500 mg, 750 mg e 1000 mg, solução para infusão IV 100 mg/mL [frasco-ampola 5 mL = 500 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

246. Levocetirizina (dicloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 5 mg/mL [0,25 mg/gota], solução oral 0,5 mg/mL, comprimidos revestidos 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

247. Levodopa + Benserazida / Carbidopa

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos dispersíveis 50 mg + 12,5 mg, comprimidos 100 mg + 25 mg e 200 mg + 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

248. Levodropropizina

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 30 mg/5 mL [6 mg/mL], gotas 60 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

249. Levofloxacino

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral, comprimidos revestidos 250 mg, 500 mg e 750 mg, solução para infusão IV 5 mg/mL [bolsa 100 mL = 500 mg], colírio oftálmico 0,5%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

250. Levomepromazina

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 40 mg/mL [1 mg/gota], comprimidos 25 mg e 100 mg, solução injetável 25 mg/5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

251. Levosimendana

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução concentrada para infusão 2,5 mg/mL [frasco-ampola 5 mL = 12,5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

252. Levotiroxina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 100 mcg/mL, comprimidos 12,5 mcg, 25 mcg, 37,5 mcg, 50 mcg, 62,5 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg e 200 mcg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

253. Lidocaína (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1% e 2% sem vasoconstritor [ampolas e frascos 20 mL], spray tópico 10%, gel/pomada tópica 2% e 5%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

254. Linezolida

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para infusão IV 2 mg/mL [bolsa 300 mL = 600 mg], comprimidos 600 mg, pó para suspensão oral 100 mg/5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

255. Lisdexanfetamina (dimesilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 30 mg, 50 mg e 70 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

256. Lítio (carbonato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 300 mg e comprimidos de liberação prolongada 450 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

257. Loperamida (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 2 mg
-----------------------	------------------

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

258. Loratadina

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 1 mg/mL [5 mg/5 mL], comprimidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

259. Lorazepam

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 1 mg e 2 mg, solução injetável 2 mg/mL e 4 mg/mL [ampolas 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

260. Losartana potássica

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

261. Macrogol 3350 / 4000 (Polietilenoglicol - PEG)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução oral em sachês de 4 g, 5 g, 8 g, 10 g, 14 g, 17 g ou a granel
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

262. Mebendazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 20 mg/mL [100 mg/5 mL], comprimidos 100 mg e 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

263. Meloxicam

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 7,5 mg e 15 mg, solução injetável 15 mg/1,5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

264. Meropenem (tri-hidratado)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

265. Mesalazina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos e sachês de liberação prolongada 400 mg, 500 mg, 800 mg, 1000 mg e 1200 mg, supositórios 250 mg, 500 mg e 1000 mg, enema 1 g e 3 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

266. Metadona (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 5 mg e 10 mg, solução injetável 10 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

267. Metformina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 500 mg, 850 mg e 1000 mg, comprimidos de liberação prolongada XR 500 mg, 750 mg e 1000 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

268. Metilfenidato (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos de liberação imediata 10 mg, cápsulas de liberação modificada 10 mg, 20 mg, 30 mg e 40 mg, comprimidos de liberação osmótica prolongada 18 mg, 27 mg, 36 mg e 54 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

269. Metilprednisolona (succinato sódico / acetato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 125 mg, 500 mg e 1000 mg, suspensão injetável de depósito 40 mg/mL e 80 mg/mL, comprimidos 4 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

270. Metoclopramida (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 4 mg/mL [0,2 mg/gota], solução oral 1 mg/mL, comprimidos 10 mg, solução injetável 5 mg/mL [ampola 2 mL = 10 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTES CLÍNICAS	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
-----------------	--

271. Metoprolol (tartarato / succinato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg, comprimidos de liberação prolongada 25 mg, 50 mg e 100 mg, solução injetável 1 mg/mL [ampola 5 mL = 5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTES CLÍNICAS	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

272. Metronidazol / Benzoilmetronidazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 40 mg/mL [200 mg/5 mL de benzoilmetronidazol], comprimidos 250 mg e 400 mg, solução para infusão IV 5 mg/mL [bolsa 100 mL = 500 mg], gel vaginal 0,8%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTES CLÍNICAS	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

273. Micafungina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTES CLÍNICAS	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

274. Miconazol (nitrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gel oral 20 mg/g [2%], creme dermatológico 20 mg/g [2%], loção tópica 20 mg/mL [2%], creme vaginal 20 mg/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTES CLÍNICAS	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

275. Midazolam (cloridrato / maleato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral/xarope 2 mg/mL, comprimidos 7,5 mg e 15 mg, solução injetável 1 mg/mL [ampola 5 mL = 5 mg] e 5 mg/mL [ampolas 3 mL = 15 mg e 10 mL = 50 mg]
-----------------------	--

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

276. Milrinona (lactato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 1 mg/mL [ampolas de 10 mL = 10 mg e 20 mL = 20 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

277. Minociclina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

278. Mometasona (furoato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal aquoso 50 mcg/dose, pó inalatório 200 mcg e 400 mcg/dose, creme e pomada dermatológica 1 mg/g [0,1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

279. Montelukaste de sódio

APRESENTAÇÕES DA BASE	grânulos orais em sachê 4 mg, comprimidos mastigáveis 4 mg e 5 mg, comprimidos revestidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

280. Morfina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 10 mg/mL [gotas], comprimidos 10 mg e 30 mg, comprimidos de liberação prolongada 30 mg e 60 mg, solução injetável sem conservantes 0,1 mg/mL e 0,2 mg/mL [ampolas 1 mL], solução injetável 1 mg/mL [ampola 2 mL] e 10 mg/mL [ampolas 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

281. Moxifloxacino (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 400 mg, solução para infusão IV 400 mg/250 mL, colírio oftálmico 0,5%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

282. Mupirocina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica 20 mg/g [2%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

283. Naloxona (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,4 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

284. Naproxeno / Naproxeno sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 25 mg/mL [125 mg/5 mL], comprimidos 250 mg e 500 mg, comprimidos revestidos 275 mg e 550 mg
-----------------------	--

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

285. Neomicina + Bacitracina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica e oftálmica com sulfato de neomicina 5 mg/g + bacitracina zíncica 250 UI/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

286. Neostigmina (metilsulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,5 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

287. Nicardipino (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada 25 mg/10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

288. Niclosamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos mastigáveis 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

289. Nifedipino

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 10 mg e 20 mg, comprimidos de liberação retardada/prolongada [Retard/OROS] 10 mg, 20 mg, 30 mg e 60 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

290. Nimesulida

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 50 mg/mL [2,5 mg/gota], suspensão oral 10 mg/mL [50 mg/5 mL], comprimidos 100 mg [para > 12 anos]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

291. Nistatina

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 100.000 UI/mL, creme dermatológico 100.000 UI/g, creme vaginal 25.000 UI/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

292. Nistatina + Óxido de zinco

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica 100.000 UI/g + 200 mg/g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

293. Nitazoxanida

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 20 mg/mL [100 mg/5 mL], comprimidos revestidos 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

294. Nitroglicerina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 5 mg/mL [ampolas 5 mL = 25 mg e 10 mL = 50 mg], comprimidos sublinguais 0,4 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

295. Nitrofurantoína

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 25 mg/5 mL [5 mg/mL], cápsulas 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

296. Nitroprussiato de sódio

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg com diluente estéril
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

297. Noradrenalina (Hemitartarato de norepinefrina)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada para infusão 2 mg/mL hemitartrato [1 mg/mL norepinefrina base, ampola 4 mL = 8 mg hemitartrato / 4 mg base]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

298. Nortriptilina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

299. Octreotida (acetato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 0,05 mg/mL, 0,1 mg/mL e 0,5 mg/mL [ampolas 1 mL], suspensão injetável de liberação prolongada LAR 10 mg, 20 mg e 30 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

300. Olanzapina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 2,5 mg, 5 mg e 10 mg, comprimidos orodispersíveis 5 mg e 10 mg, pó liofilizado para solução injetável 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

301. Óleo mineral (Petrolato líquido)

APRESENTAÇÕES DA BASE	emulsão oral 100%, emulsão oral associada a fenoltaleína
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

302. Omalizumabe

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável 75 mg e 150 mg, solução injetável em seringa preenchida 75 mg e 150 mg SC
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

303. Omeprazol (magnésico / sódico)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral em sachês de 20 mg e 40 mg, cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes 10 mg, 20 mg e 40 mg, pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

304. Ondansetrona (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 2 mg/5 mL [0,4 mg/mL], gotas 2 mg/mL, comprimidos revestidos 4 mg e 8 mg, comprimidos orodispersíveis 4 mg e 8 mg, filme orodispersível 4 mg e 8 mg, solução injetável 2 mg/mL [ampolas 2 mL = 4 mg e 4 mL = 8 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

305. Oseltamivir (fosfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 6 mg/mL [frasco 60 mL = 360 mg], cápsulas 30 mg, 45 mg e 75 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

306. Oxacilina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

307. Oxcarbazepina

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 60 mg/mL [6%], comprimidos revestidos 300 mg e 600 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

308. Óxido de zinco

APRESENTAÇÕES DA BASE	pasta d'água 25%, pomada dermatológica associada a vitaminas A e D
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

309. Oxitocina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 5 UI/mL e 10 UI/mL [ampolas 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

310. Palivizumabe

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável frasco-ampola 50 mg [0,5 mL] e 100 mg [1,0 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

311. Pantoprazol sódico

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos gastrorresistentes 20 mg e 40 mg, pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

312. Paracetamol (Acetaminofeno)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 200 mg/mL [10 mg/gota a 15 mg/gota conforme fabricante], solução oral 32 mg/mL [160 mg/5 mL], comprimidos 500 mg e 750 mg, comprimidos mastigáveis 80 mg e 160 mg, supositórios 150 mg e 250 mg, solução para infusão IV 10 mg/mL [bolsa 100 mL = 1000 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

313. Penicilamina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

314. Periciazina

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 10 mg/mL [1% pediátrico - 1 gota = 0,25 mg] e 40 mg/mL [4%], comprimidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

315. Permetrina

APRESENTAÇÕES DA BASE	loção tópica 1% e 5%, xampu 1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

316. Picossulfato de sódio

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 7,5 mg/mL [0,5 mg/gota], cápsulas 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

317. Pilocarpina (cloridrato / nitrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oftálmica/colírio 1%, 2% e 4%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

318. Pimecrolimo

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme dermatológico 10 mg/g [1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

319. Piperacilina + Tazobactam

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 2,25 g [2 g + 0,25 g] e 4,5 g [4 g + 0,5 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

320. Pirantel (pamoato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 50 mg/mL [250 mg/5 mL], comprimidos 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

321. Pirazinamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 30 mg/mL [150 mg/5 mL], comprimidos 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

322. Piridostigmina (brometo)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 60 mg e comprimidos de liberação prolongada 180 mg, xarope 12 mg/mL [60 mg/5 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

323. Piridoxina (Vitamina B6)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 40 mg, 50 mg e 100 mg, solução injetável 100 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

324. Poliestirenosulfonato de cálcio

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral e retal em envelopes de 30 g [Sorcal]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

325. Polimixina B (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500.000 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

326. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas otológicas / suspensão otológica
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

327. Polivitamínicos pediátricos com minerais

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas orais, suspensão oral, comprimidos mastigáveis
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

328. Poractanto alfa (Surfactante pulmonar porcino)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão intratraqueal 80 mg/mL [frascos 1,5 mL = 120 mg e 3,0 mL = 240 mg de fosfolípidios]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

329. Posaconazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 40 mg/mL, comprimidos de liberação retardada 100 mg, solução injetável IV 300 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

330. Pralidoxima (mesilato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg e 1000 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

331. Praziquantel

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 600 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

332. Prednisolona (fosfato sódico / acetato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 3 mg/mL [equivalente a 4,02 mg/mL de fosfato] e 1 mg/mL, comprimidos 5 mg, 20 mg e 40 mg, colírio oftálmico 1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

333. Prednisona

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 5 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

334. Pregabalina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 25 mg, 50 mg, 75 mg e 150 mg
-----------------------	---------------------------------------

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

335. Primidona

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

336. Probióticos pediátricos (Lactobacillus reuteri / rhamnosus / Saccharomyces boulardii)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas orais, sachês/pó liofilizado para suspensão oral, cápsulas
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

337. Prometazina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope/solução oral 1 mg/mL [5 mg/5 mL], comprimidos 25 mg, solução injetável 25 mg/mL [ampola 2 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

338. Propiltiouracila

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

339. Propofol

APRESENTAÇÕES DA BASE	emulsão injetável 1% [10 mg/mL, ampolas 20 mL = 200 mg e frascos 50 mL e 100 mL] e 2% [20 mg/mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

340. Propranolol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 2 mg/mL e 4 mg/mL, comprimidos 10 mg, 40 mg e 80 mg, solução injetável 1 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

341. Protamina (cloridrato / sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 10 mg/mL [1000 UI anti-heparina/mL, ampola 5 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

342. Quetiapina (fumarato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg, comprimidos de liberação prolongada 50 mg, 200 mg e 300 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

343. Racecadotril

APRESENTAÇÕES DA BASE	grânulos para suspensão oral em sachês de 10 mg e 30 mg, cápsulas 100 mg
-----------------------	--

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

344. Ranitidina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope/solução oral 15 mg/mL [75 mg/5 mL], comprimidos 150 mg e 300 mg, solução injetável 25 mg/mL [ampola 2 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

345. Remifentanila (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg, 2 mg e 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

346. Retinol (Vitamina A / Palmitato de retinol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 50.000 UI/mL, 100.000 UI/mL e 200.000 UI/mL, cápsulas 50.000 UI e 100.000 UI, ampolas injetáveis IM
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

347. Ribavirina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 250 mg, solução oral
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

348. Rifampicina

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 20 mg/mL [100 mg/5 mL], cápsulas 300 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

349. Risperidona

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 1 mg/mL [1 gota = 0,05 mg], comprimidos revestidos 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg e 3 mg, comprimidos orodispersíveis 0,5 mg, 1 mg e 2 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

350. Rufinamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 200 mg e 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

351. Rupatadina (fumarato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oral 1 mg/mL, comprimidos 10 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

352. Sais de Reidratação Oral (SRO)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução oral em envelopes de 27,9 g [para 1000 mL de água] ou sachês pediátricos para 200 mL e 500 mL, solução pronta para uso oral [45 mEq/L e 75 mEq/L]
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

353. Salbutamol (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 2 mg/5 mL [0,4 mg/mL], solução para nebulização/gotas 5 mg/mL, aerossol inalatório pressurizado 100 mcg/puff, solução injetável 0,5 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

354. Salmeterol (xinafoato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	aerossol inalatório pressurizado 25 mcg/puff, pó para inalação 50 mcg/dose, associado a fluticasona [25/50 mcg, 25/125 mcg, 25/250 mcg, 50/100 mcg, 50/250 mcg e 50/500 mcg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

355. Secnidazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 450 mg e 900 mg em frasco para reconstituição, comprimidos revestidos 500 mg e 1000 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

356. Sertralina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas/solução oral 20 mg/mL, comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

357. Sevelamer (carbonato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 800 mg, sachês de pó para suspensão oral 800 mg e 2,4 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

358. Sevoflurano

APRESENTAÇÕES DA BASE	líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 250 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

359. Sildenafil (citrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 10 mg/mL, comprimidos 20 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg, solução para infusão IV 0,8 mg/mL [frasco 12,5 mL = 10 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

360. Simeticona (Dimeticona)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas emulsão oral 75 mg/mL [2,5 mg a 3 mg/gota] e gotas concentradas 150 mg/mL, comprimidos 40 mg, cápsulas gelatinosas 125 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

361. Somatropina (Hormônio do crescimento recombinante - rhGH)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável ou canetas preenchidas multidose de 4 UI [1,33 mg], 12 UI [4 mg], 15 UI [5 mg], 16 UI [5,3 mg], 24 UI [8 mg], 30 UI [10 mg] e 36 UI [12 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

362. Soro antiaracnídico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

363. Soro antibotrópico (pentavalente)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

364. Soro antibotulínico (AB bivalente / trivalente)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

365. Soro anticrotático

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

366. Soro antidiftérico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL [10.000 UI]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

367. Soro antielapídico (bivalente)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

368. Soro antiescorpiônico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

369. Soro antilaquéutico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

370. Soro antitetânico

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL [5.000 UI]
-----------------------	--

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

371. Succinato de metoprolol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos de liberação prolongada 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

372. Succinilcolina (Cloreto de suxametônio)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg e 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

373. Sucralfato

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 200 mg/mL [1 g/5 mL], comprimidos mastigáveis 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

374. Sufentanila (citrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 5 mcg/mL [ampolas 2 mL = 10 mcg e 5 mL = 25 mcg] e 50 mcg/mL [ampolas 1 mL = 50 mcg e 5 mL = 250 mcg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.

FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.
---------------	--

375. Sugamadex

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 100 mg/mL [frasco-ampola 2 mL = 200 mg e 5 mL = 500 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

376. Sulfadiazina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 500 mg, suspensão oral 500 mg/5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

377. Sulfadiazina de prata

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme dermatológico 10 mg/g [1%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

378. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-trimoxazol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral pediátrica 200+40 mg/5 mL, suspensão oral forte 400+80 mg/5 mL, comprimidos 400+80 mg e 800+160 mg [Forte], solução para infusão IV 400+80 mg [ampola 5 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

379. Sulfassalazina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos gastrorresistentes 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.

POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

380. Sulfato de magnésio

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável concentrada 10% e 50% [0,5 g/mL, ampolas 10 mL = 5 g]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

381. Sulfato de zinco / Bisglicinato de zinco

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 2 mg/gota e 4 mg/mL, xarope/solução oral 10 mg/mL e 20 mg/5 mL, comprimidos dispersíveis 10 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

382. Sulfato ferroso

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 125 mg/mL [25 mg de ferro elementar/mL - aprox. 1,25 mg/gota], xarope 250 mg/5 mL [50 mg de ferro elementar/5 mL = 10 mg/mL], comprimidos revestidos 200 mg [40 mg de ferro elementar] e 300 mg [60 mg de ferro elementar]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

383. Sulpirida

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 50 mg, comprimidos 200 mg, solução oral
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

384. Tacrolimo

APRESENTAÇÕES DA BASE	pomada dermatológica 0,03% [pediátrica] e 0,1%, cápsulas 0,5 mg, 1 mg e 5 mg, solução injetável 5 mg/mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

385. Tadalafila

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 5 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

386. Teicoplanina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg e 400 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

387. Teofilina

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas de liberação prolongada 100 mg, 200 mg e 300 mg, xarope 50 mg/5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

388. Terbinafina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	creme dermatológico 10 mg/g [1%], comprimidos 125 mg e 250 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.

ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

389. Terbutalina (sulfato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	xarope 0,3 mg/mL [1,5 mg/5 mL], solução injetável 0,5 mg/mL [ampola 1 mL], pó para inalação turbuhaler 0,5 mg/dose
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

390. Tiabendazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 500 mg/5 mL, comprimidos 500 mg, pomada/loção tópica 50 mg/g [5%]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

391. Tiamazol (Metimazol)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

392. Tiamina (Vitamina B1)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg e 300 mg, solução injetável 100 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

393. Tiaprida (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 100 mg, solução injetável 100 mg/2 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

394. Tigeciclina

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

395. Timolol (maleato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução oftálmica/colírio 0,25% e 0,5%, gel oftálmico 0,1%
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

396. Tinidazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

397. Tobramicina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução para inalação 300 mg/5 mL [ampola 5 mL], solução oftálmica/colírio 0,3%, pomada oftálmica 0,3%, solução injetável 75 mg/1,5 mL
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

398. Tocoferol (Acetato de racealfatocoferol / Vitamina E)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 100 mg/mL e 400 mg/mL, cápsulas gelatinosas 400 UI
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

399. Topiramato

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas com microgrânulos [sprinkle] 15 mg e 25 mg, comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

400. Tramadol (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	gotas 100 mg/mL [50 mg/mL ou 2,5 mg/gota conforme fabricante], cápsulas 50 mg, comprimidos de liberação prolongada 50 mg e 100 mg, solução injetável 50 mg/mL [ampolas 1 mL = 50 mg e 2 mL = 100 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

401. Triancinolona acetona

APRESENTAÇÕES DA BASE	spray nasal aquoso 55 mcg/dose, pomada bucal/orabase 1 mg/g [0,1%], suspensão injetável intra-articular/IM 40 mg/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

402. Trimebutina (maleato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	suspensão oral 20 mg/mL, comprimidos 200 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

403. Urapidil

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 5 mg/mL [ampolas 5 mL = 25 mg e 10 mL = 50 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

404. Valaciclovir (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 500 mg e 1000 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

405. Valganciclovir (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para solução oral 50 mg/mL, comprimidos revestidos 450 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

406. Vancomicina (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.

SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

407. Varfarina sódica

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 1 mg, 2,5 mg e 5 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

408. Vasopressina

APRESENTAÇÕES DA BASE	solução injetável 20 UI/mL [ampola 1 mL]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

409. Verapamil (cloridrato)

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos revestidos 80 mg e 120 mg, solução injetável 2,5 mg/mL [ampola 2 mL = 5 mg]
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

410. Vigabatrina

APRESENTAÇÕES DA BASE	comprimidos 500 mg, granulado/sachê para solução oral 500 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

411. Voriconazol

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para suspensão oral 40 mg/mL, comprimidos revestidos 50 mg e 200 mg, pó liofilizado para solução injetável IV 200 mg
-----------------------	---

INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

412. Zanamivir

APRESENTAÇÕES DA BASE	pó para inalação oral em discos [Rotadisks] 5 mg/blister
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

413. Zonisamida

APRESENTAÇÕES DA BASE	cápsulas 25 mg, 50 mg e 100 mg
INDICAÇÕES / PAPEL CLÍNICO	Consultar indicação específica na bula/diretriz correspondente; não extrapolar a apresentação da lista-base para uma indicação pediátrica.
POSOLOGIA	A posologia é indicação-, idade-, peso- e função-orgânica-dependente. Este campo não reproduz dose não sustentada pelos anexos clínicos disponíveis nesta edição.
ADMINISTRAÇÃO / CONVERSÃO	Dose total = dose de referência × peso. Volume = dose total ÷ concentração confirmada. Gotas somente quando o fabricante confirmar o fator de gotejamento.
SEGURANÇA / RESTRIÇÕES	Verificar contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status regulatório antes do uso. Alta vigilância: dupla conferência independente.
FONTE CLÍNICA	Relação-base de apresentações + governança NEXO; requer fonte clínica específica para seleção terapêutica.

Referências e critérios editoriais

Fontes internas utilizadas nesta edição: relação “MEDICAÇÕES EM PEDIATRIA”; modelo “Guia de Farmacoterapia Pediátrica — Vol. 1”; Arquivo-Mestre/Source Registry NEXO; Guia Rápido de Medicamentos em Pediatria RioSaúde; Manual Farmacêutico institucional. O manual histórico de 2011 é tratado como referência complementar e não como árbitro de atualização.

A relação-base contém apresentações, mas não fornece, para todos os 413 itens, monografias clínicas completas com indicação, ajuste renal/hepático, interações, estabilidade e compatibilidade. Por isso, esta edição não cria doses ausentes. O preenchimento clínico integral exige ingestão individual de fontes por fármaco e revisão humana, conforme a própria governança NEXO.

Checklist de uso seguro

■ indicação confirmada ■ peso/idade confirmados ■ alergias ■ função renal/hepática ■ apresentação/concentração ■ mg/kg/dose e mg/kg/dia ■ máximo absoluto ■ conversão reversa ■ via/diluição/infusão ■ interações/contraindicações ■ status off-label ■ dupla checagem em alta vigilância